

Katalog eksperymentów *interoceptywnych*

Sześć protokołów wywoływania odczuć. Każdy testuje inną katastroficzną prognozę — dopasuj ćwiczenie do swojego lęku.

CZAS: 15–20 min na ćwiczenie 3–5× w tygodniu, 4–8 tyg.

ŹRÓDŁO: Barlow & Craske (1989); Antony i wsp. (2006); Craske i wsp. (2014)

JAK UŻYWAĆ

Z dziennika ataków wybierz **2-3 odczucia** najbardziej dla Ciebie lękotwórcze (kołatanie, duszność, zawroty, mrowienie). Dla każdego dobierz ćwiczenie z katalogu, które dokładnie to wywołuje. Wykonaj według protokołu (prognoza → ćwiczenie → wynik). Powtórzenia 3–5× z wariacjami (różne pory, różne miejsca), aż wygasną prognozy.

DLACZEGO TO DZIAŁA

Sama instrukcja „wywołaj odczucia paniki” nie wystarcza. Pacjent nie wie konkretnie, jak wywołać kołatanie ani jak długo. Bez protokołu dawkuje się *subprogowo* — nie wywołuje pełnego odczucia, niczego nie testuje. Craske i wsp. (2014): **match-to-fear** jest centralny — ćwiczenie musi dopasować się do Twoich głównych odczuć. Wykonywanie ćwiczenia, które *nie* wywołuje Twoich lęków (kręcenie krzesła gdy boisz się kołatania), daje zerowy efekt.

01 Sześć protokołów — dopasuj do swojego lęku

ĆWICZENIE + CZAS	INSTRUKCJA WYKONANIA	TESTOWANA PROGNOZA	TYPOWY WYNIK
Hiperwentylacja 60 s	Szybki, głęboki oddech 30 cykli/min przez całe 60 s. Pełne wdechy klatką.	„Duszność = uduszę się” „Mrowienie = udar”	Zawroty, mrowienie, nierealność. Nikt nie mdleje, nie umiera.
Obrót na krześle 30 s	Szybkie kręcenie przy biurku, jak najszybciej, oczy otwarte.	„Zawroty = utrata przytomności” „Stracę kontrolę”	Silne zawroty, ustępują w 30 s po zatrzymaniu. Bez utraty przytomności.
Bieg w miejscu 60–90 s	Wysokie tempo z uniesieniem kolan, do tętna 120+. Bez zatrzymania.	„Kołatanie = zawał” „Serce stanie”	Silne kołatanie, pocenie, ciężki oddech. Serce zwalnia po 2-3 min.
Słomka — wąska 120 s	Cienka słomka (średnica 5 mm), oddech wyłącznie przez nią, nos zatkany palcami.	„Ograniczenie oddechu = zaduszenie”	Silna duszność, „brak powietrza”. Tlen w normie, można wytrzymać.
Wpatrywanie 120 s	Nieruchomy wzrok na czarnej kropce/punkcie na ścianie. Bez mrugania na siłę.	„Nierealność = szaleństwo” „Stracę kontrolę nad umysłem”	Uczucie nierealności, „nie jestem tu”. Mija po 2-3 min normalnego patrzenia.
Wstrzymanie oddechu 30 s	Pełny wdech, zatrzymanie przez 30 s (lub do silnego dyskomfortu).	„Brak powietrza = uduszenie”	Silna potrzeba oddechu, ucisk w klatce. Ciało samo „każe” oddychać — bezpieczne.

02 Mój wybór — match-to-fear z dziennika

Otwórz dziennik ataków. Wypisz **3 odczucia**, które najczęściej Cię niepokoją + katastrofę z każdym związaną + ćwiczenie z katalogu (1), które dokładnie to wywołuje.

#	MOJE ODCZUCIE	KATASTROFICZNA INTERPRETACJA	ĆWICZENIE Z KATALOGU (1)
1			
2			
3			

03 Dziennik powtórzeń — 8 sesji

Po każdej sesji zapisz wybrane ćwiczenie, max SUDS, prognozę spełnioną/nie i wnioski. Cel: SUDS spada z 70–80 do 20–30 po 6–8 sesjach.

#	DATA	ĆWICZENIE + CZAS	MAX SUDS	PROGNOZA SPEŁNIONA?	WNIOSEK
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
8					

Klucz: Antony i wsp. (2006) rozbudowali katalog na podstawie danych z 500+ pacjentów — przestało to być „eksperymentem”, a stało się *protokołem z mierzalnymi efektami*. Wykonywanie nieodpowiedniego ćwiczenia (np. wpatrywanie się, gdy boisz się głównie kołatania) daje zerowy efekt. **Match-to-fear** jest niepodważalny — wybierz dokładnie te ćwiczenia, które wywołują Twoje główne odczucia z dziennika.